Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Revisão Flash · Sessão 09

Afecções Urológicas

O essencial para a prova em uma página

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Revisado pela Profa. Fernanda Parreiras

Resumo elaborado pelo monitor para orientar o estudo. Não é referência bibliográfica *e pode conter erros: para estudo, prova e recursos, valem as aulas, as diretrizes e as fontes indicadas pela disciplina.*

Afecções urológicas

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

AINE na cólica e descompressão se houver febre; sonda na retenção; escroto agudo é torção até prova em contrário; e nunca sondar com sangue no meato.

1. **Cólica renal:** AINE é a 1ª escolha. Opioide é 2ª opção.
2. **Imagem:** TC sem contraste confirma. Gestante e criança começam pela ultrassonografia.
3. **Cálculo < 5 mm no ureter distal:** 89% eliminam sozinhos.
4. α-bloqueador: para cálculo do ureter distal de 5 a 10 mm.
5. **Obstrução + febre:** duplo J ou nefrostomia + antibiótico; o cálculo fica para depois.
6. **Retenção:** sondagem de alívio; se a sonda não passa, cistostomia.
7. **Torção:** janela de 4–6 h; o Doppler não pode atrasar a cirurgia.
8. **Sangue no meato:** não sondar; uretrografia antes.

Torção × epididimite

	Torção	Epididimite
Cremastérico	Ausente	Presente
Prehn	Não alivia	Alivia
Doppler	Sem fluxo	Hiperfluxo

Pegadinha

Fluxo ao Doppler, reflexo presente ou Prehn positivo não excluem torção. Na sondagem, só insufle o balão depois de avançar até a bifurcação e ver urina.

Checklist antes da prova

- ☐ Sei a analgesia e a imagem da cólica renal
- ☐ Sei quando descomprimir o rim
- ☐ Sei conduzir a retenção urinária
- ☐ Sei os remédios da HPB e quando operar
- ☐ Diferencio as três causas de escroto agudo
- ☐ Separo priapismo isquêmico do não isquêmico
- ☐ Sei a técnica e as contraindicações da sondagem